



NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE: SAMUEL PALACIO		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: UROLOGÍA	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: **PRIAPISMO**

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

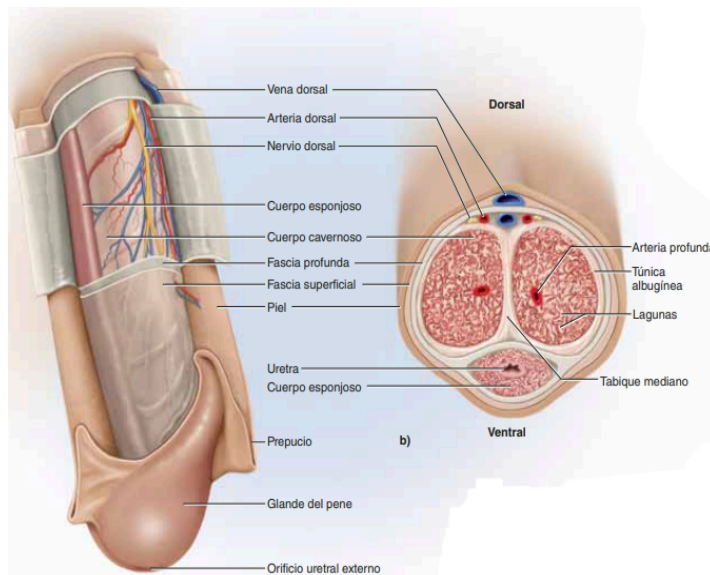
• ETAPA DE PLANEACIÓN:

1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción)

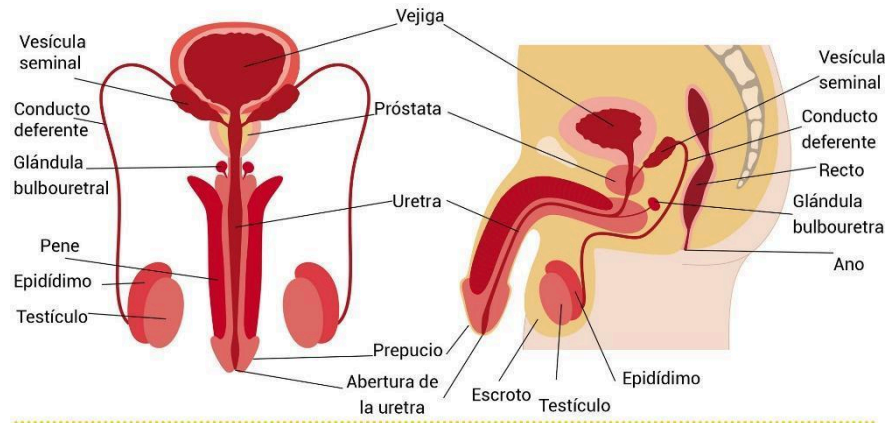
Aliviar la erección persistente y dolorosa para prevenir el daño tisular permanente, la fibrosis de los cuerpos cavernosos y la disfunción eréctil.

1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

ANATOMÍA



El pene es un órgano externo del aparato reproductor masculino compuesto por varias estructuras anatómicas, En su base se encuentra la raíz, que conecta el pene a la pelvis; el cuerpo es la parte media, compuesta por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos son tejidos cilíndricos que se llenan de sangre para provocar una erección que se extiende hasta el glande, o punta del pene, el glande es la cabeza expandida en el extremo distal del pene, con un orificio uretral externo en su punta. La parte externa mide 8 a 10 cm de largo y 3 cm de diámetro cuando está flácido (sin erección); las dimensiones típicas de un pene erecto son de 13 a 18 cm de largo y 4 cm de diámetro.

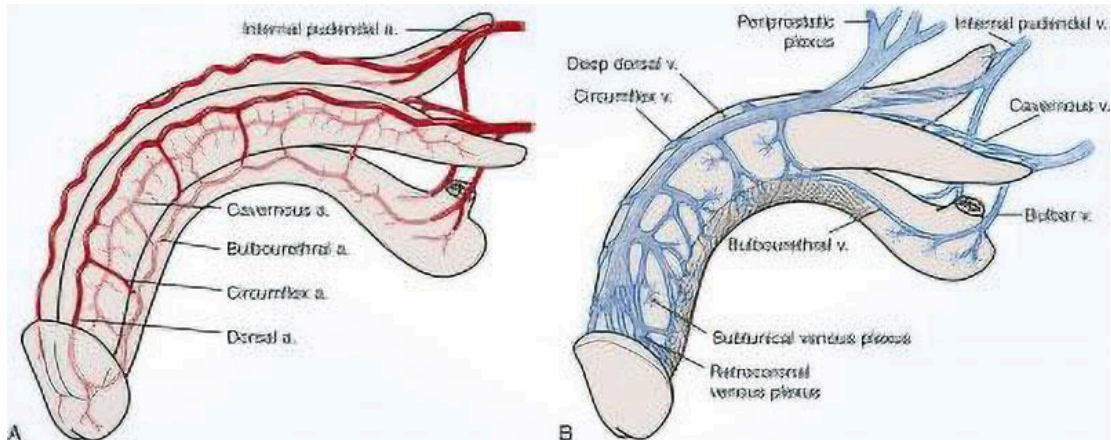


Genitales Externos:

- Pene (compuesto por 2 cuerpos cavernosos y 1 cuerpo esponjoso) que se encuentra recubierto por el prepucio. Su cabeza se llama glande
- Escroto que recubre los testículos

Genitales Internos:

- Testículos: forman las células sexuales o gametos (espermatozoides)
- Epidídimo: donde se entrenan los espermatozoides
- Conducto deferente: Transportan los espermatozoides
- Vesículas Seminales y Próstata: Les dan alimento a los espermatozoides.
- Uretra: Transportan los espermatozoides hacia el exterior a través del pene





El pene está irrigado por ramas de la arteria pudenda interna, que a su vez es una rama de la arteria iliaca interna. La sangre sale del pene por venas.

ARTERIAS QUE IRRIGAN EL PENE

- **Arteria peneana común:** Rama de la arteria pudenda interna que irriga las estructuras profundas del pene
- **Arteria bulbo uretral:** Irriga el bulbo, uretra, cuerpo esponjoso y glande
- **Arteria dorsal del pene:** Irriga el glande, cuerpo esponjoso y uretra
- **Arteria cavernosa:** Irriga los cuerpos cavernosos, que se llenan de sangre durante la erección
- **Arteria del bulbo del pene:** Irriga la porción posterior del cuerpo cavernoso y las glándulas bulbo uretrales

VENAS QUE DRENAN EL PENE

Vena pudenda externa superficial, Vena dorsal profunda del pene.

Función de las arterias en la erección

- Durante la erección, las arterias se dilatan para aumentar el flujo sanguíneo al pene
- La sangre llena los cuerpos cavernosos, lo que produce la erección

INERVACIÓN DEL PENE

- Los nervios pudendos y los nervios cavernosos son los responsables de la inervación del pene
- Los nervios pudendos se encargan de la inervación motora y sensitiva
- Los nervios cavernosos son los responsables de la función eréctil

FISIOLOGÍA

La erección es un proceso **neurovascular** con fases:

- **Estimulación:** Estímulos sensoriales o mentales activan el sistema parasimpático (S2-S4).
- **Liberación de óxido nítrico (NO):** El NO relaja el músculo liso de los cuerpos cavernosos.
- **Vasodilatación:** Aumento del flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos.
- **Compresión venosa:** La sangre queda atrapada al comprimirse las venas, produciendo la erección.

Fisiología de la eyaculación: Tiene dos fases:

- **Emisión** (control simpático): transporte del semen hacia la uretra prostática.
- **Expulsión** (control somático): contracciones rítmicas del músculo bulbo cavernoso y otros músculos perineales.

6. Relajación (Detumescencia)

- Tras la eyaculación, se activa el sistema simpático.
- La vasoconstricción reduce el flujo sanguíneo, y el pene retorna a su estado flácido.

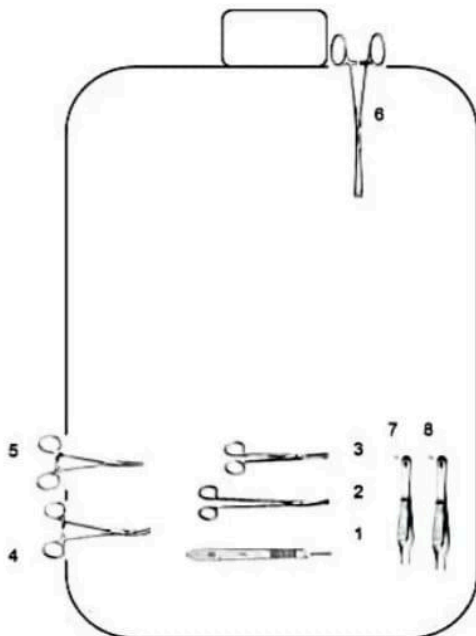


1.3. Lista de chequeo:

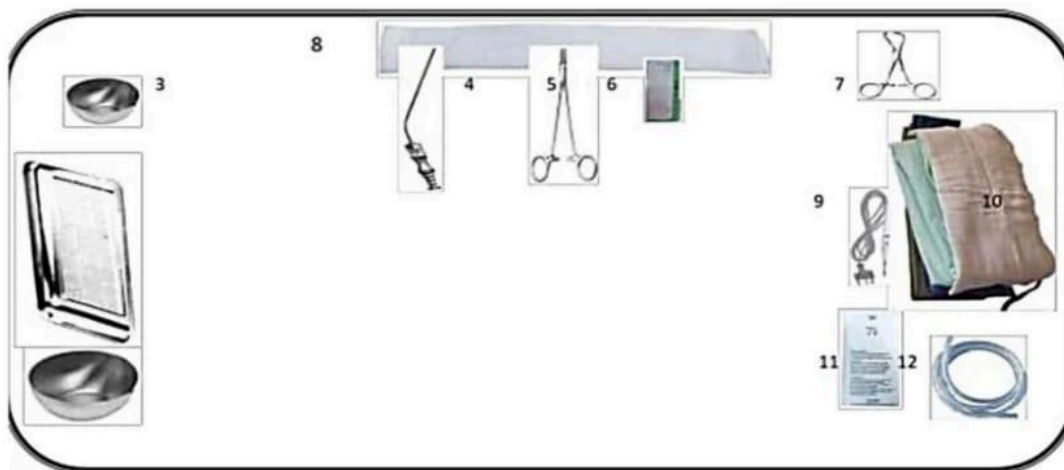
INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FÁRMACOS Y SOLUCIONES
Equipo de plastia	Paquete de ropa	Catgut cromado 4/0-	Solución salina Suero heparinizado (100cc más un centímetro de heparina)
	Lapicero del Electrocauterio	5/0 con aguja tres octavo de círculo pequeña Vicryl 2/0,3/0 con aguja de medio circulo pequeña	
	Hoja de Bisturi #15		
	Compresas		
	Guantes		
	Aseptojeringa		
	Gasitas		
	4 campos		
	4 agujas hipodérmicas		
	2 jeringas de 20 cc		
	Cocas		
	Miniset número 20		

- ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).



1. Mango de Bisturí 3 Hoja 15
2. Tijeras de Metzembraum
3. Tijeras de Mayo recta
4. Pinzas Kelly curva
5. Pinzas Kelly recta
6. Pinzas Allix
7. Pinza de Disección Adson sin garra
8. Pinzas de Disección Adson con garra



1. Equipo Plastia
2. Coca con suero
3. coca
4. Cánula de Yankawer
5. Portaguja
6. Suturas
7. Pinza de campo de Backhouse
8. compresa
9. Lapicero del electrobisturí
10. paquete de ropa
11. Guantes
12. Caucho de succión

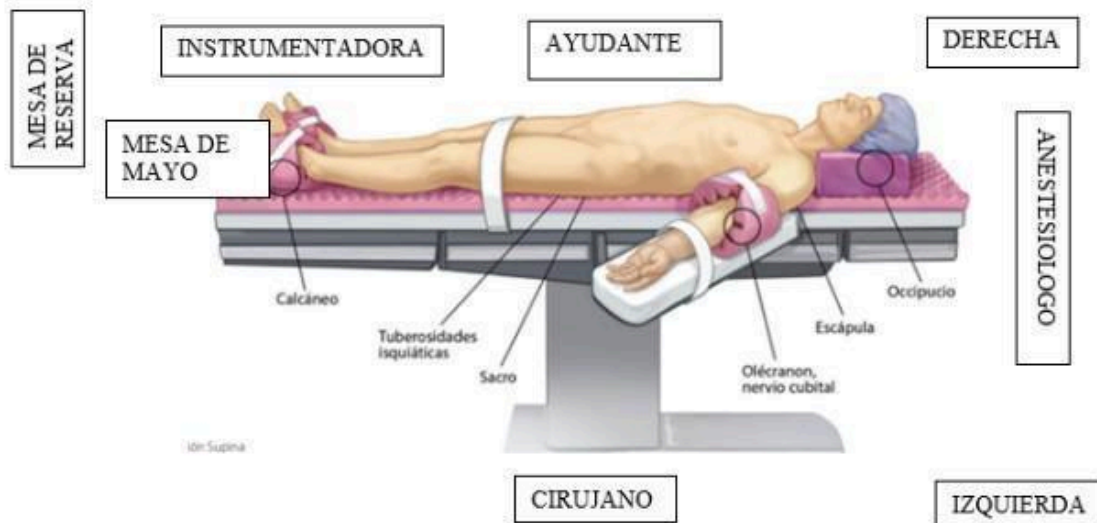


2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

Decúbito supino



2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):



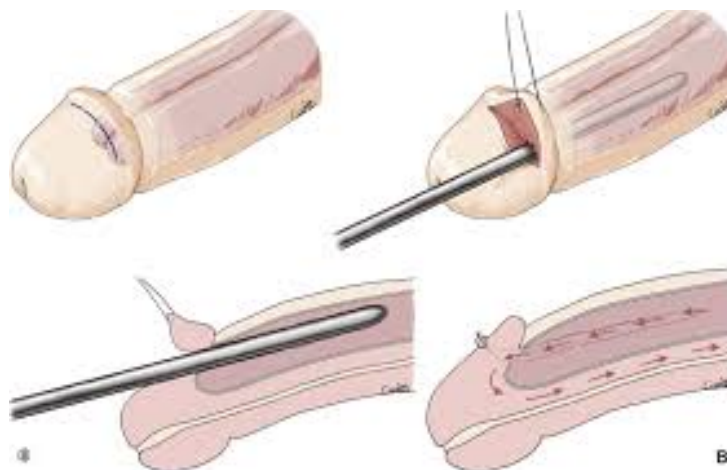
- ETAPA DE EJECUCION:

- **Anestesia (escribir el tipo de anestesia):** Anestesia raquídea





- **Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):** Incisión circunferencial en la base del glande del pene



- **Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico quirúrgica con el instrumental a usar).**

TÉCNICA	INSTRUMENTAL
Incisión circunferencial en la base del glande del pene	Mango bisturí # 3 Hoja de bisturí 15
Resecar la piel dejando descubierto el pene, se expone el cuerpo cavernoso y esponjoso	Tijera de plastia
Realizar una ventanilla entre el cuerpo esponjoso y cavernoso	Pinza mosquito curva
Realizar una fistula para que circule la sangre	
Cierre y curación	Porta agujas de plastia Adson sin garra Gasas Catgut cromado 4/0